

Incontinence urinaire et prolapsus génital

C. Achdari

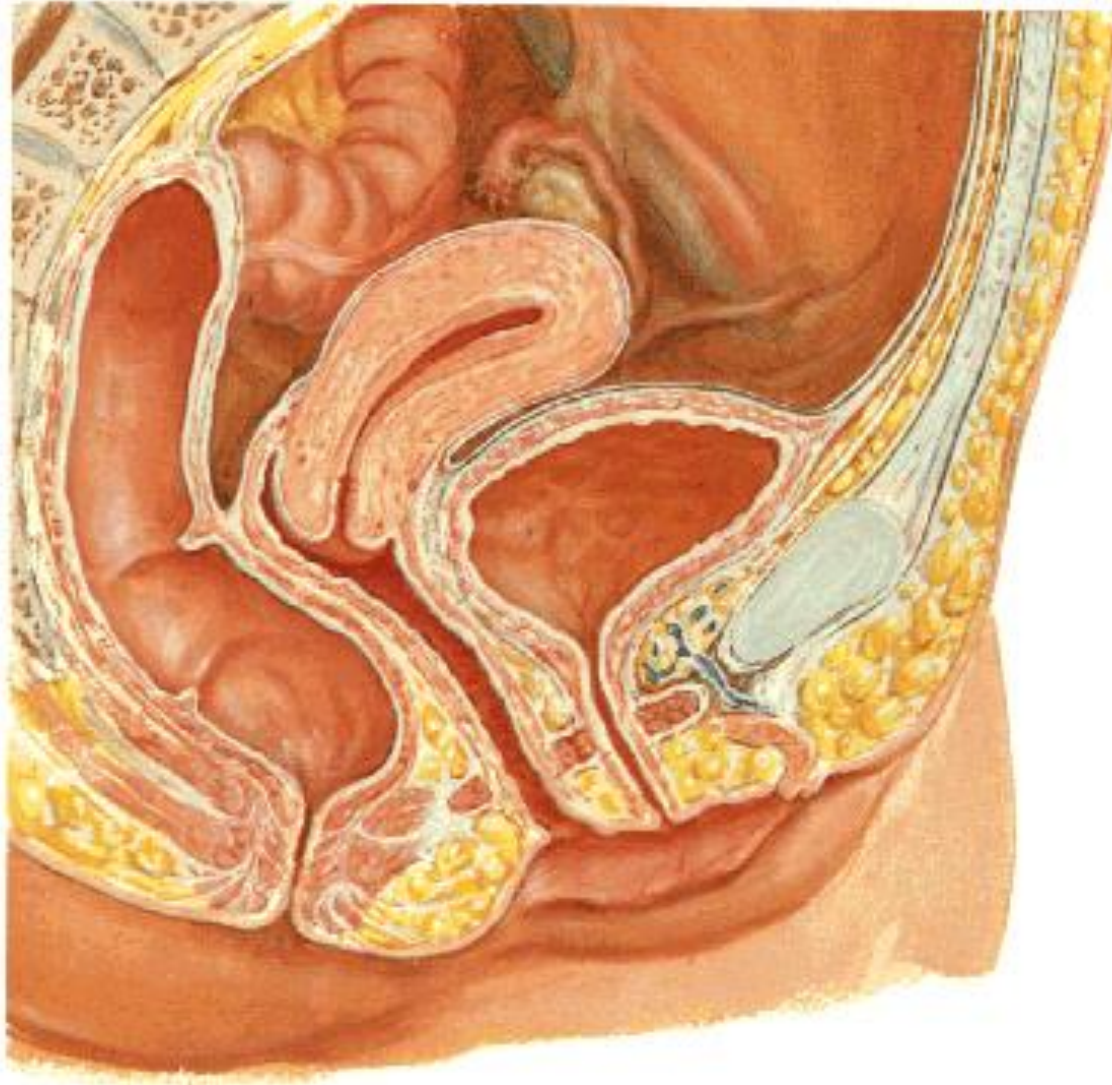
Unité d'urogynécologie

Service de gynécologie, DFME

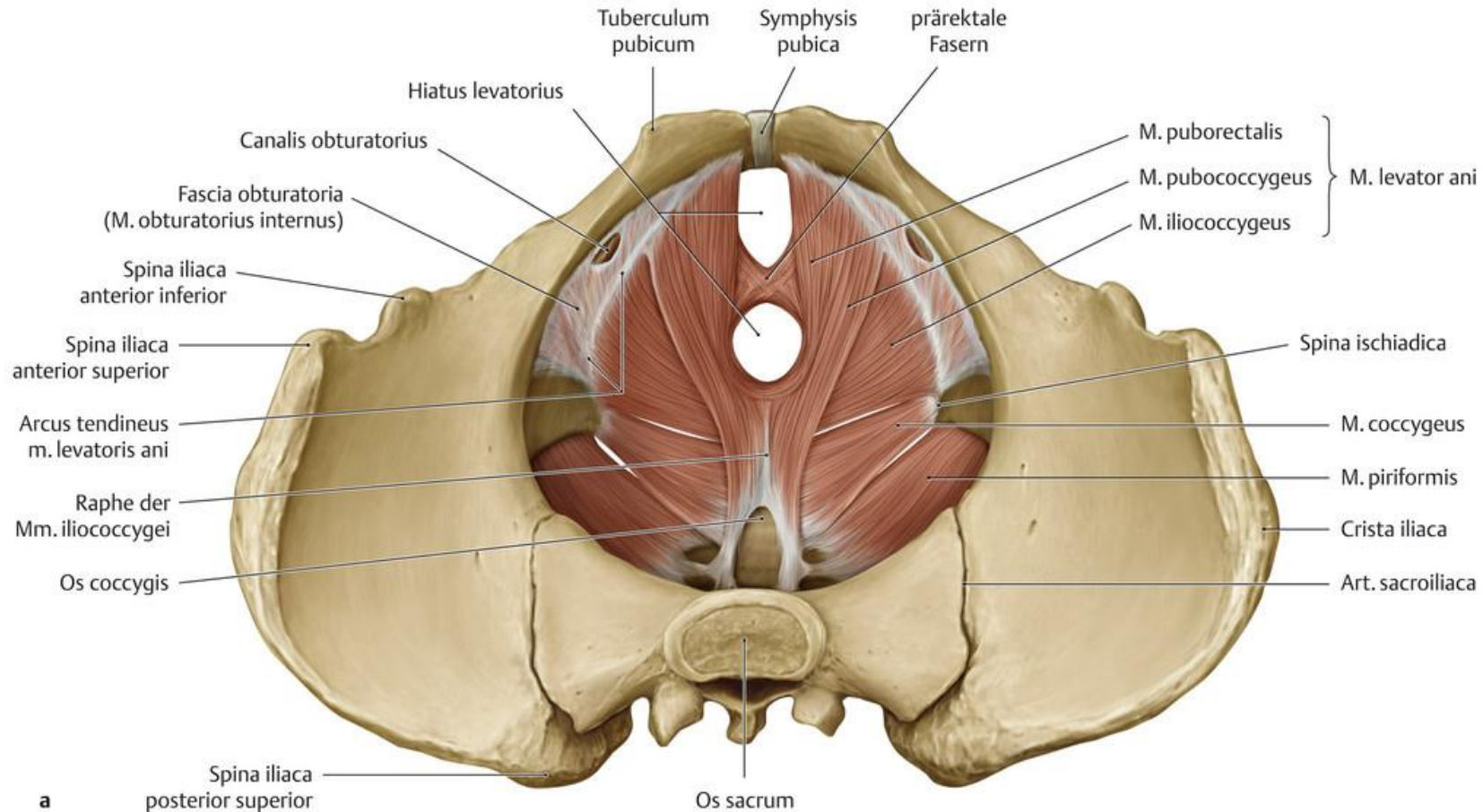
Mes objectifs

- Reconnaître les symptômes et la présentation clinique d'un prolapsus
- Comprendre les mécanismes qui mènent au prolapsus
- Connaître les différents types d'incontinence urinaire chez la femme
- Prendre les mesures initiales correctes en cas d'incontinence urinaire

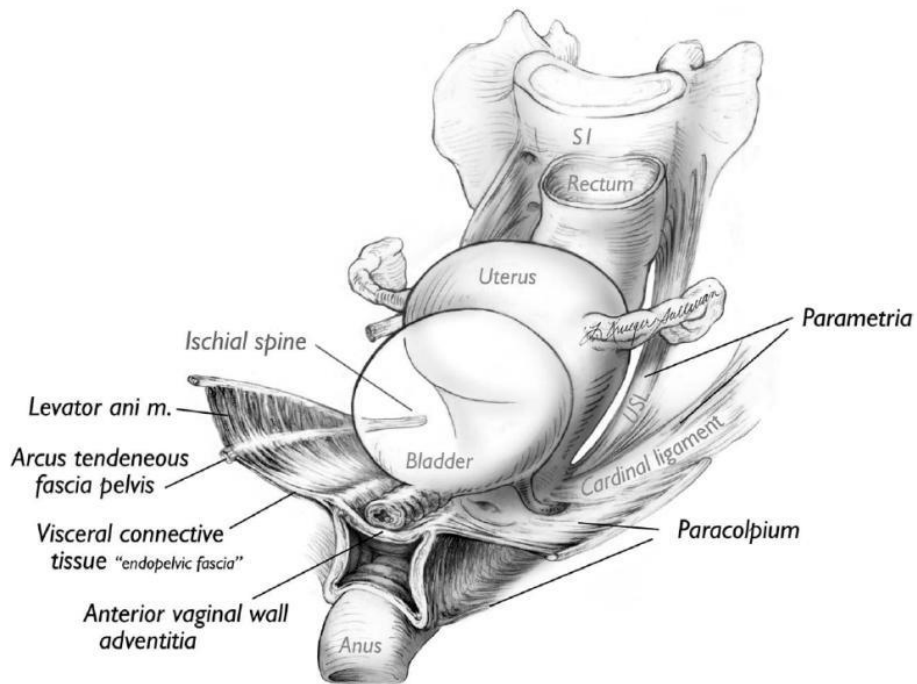
Organes pelviens de la femme



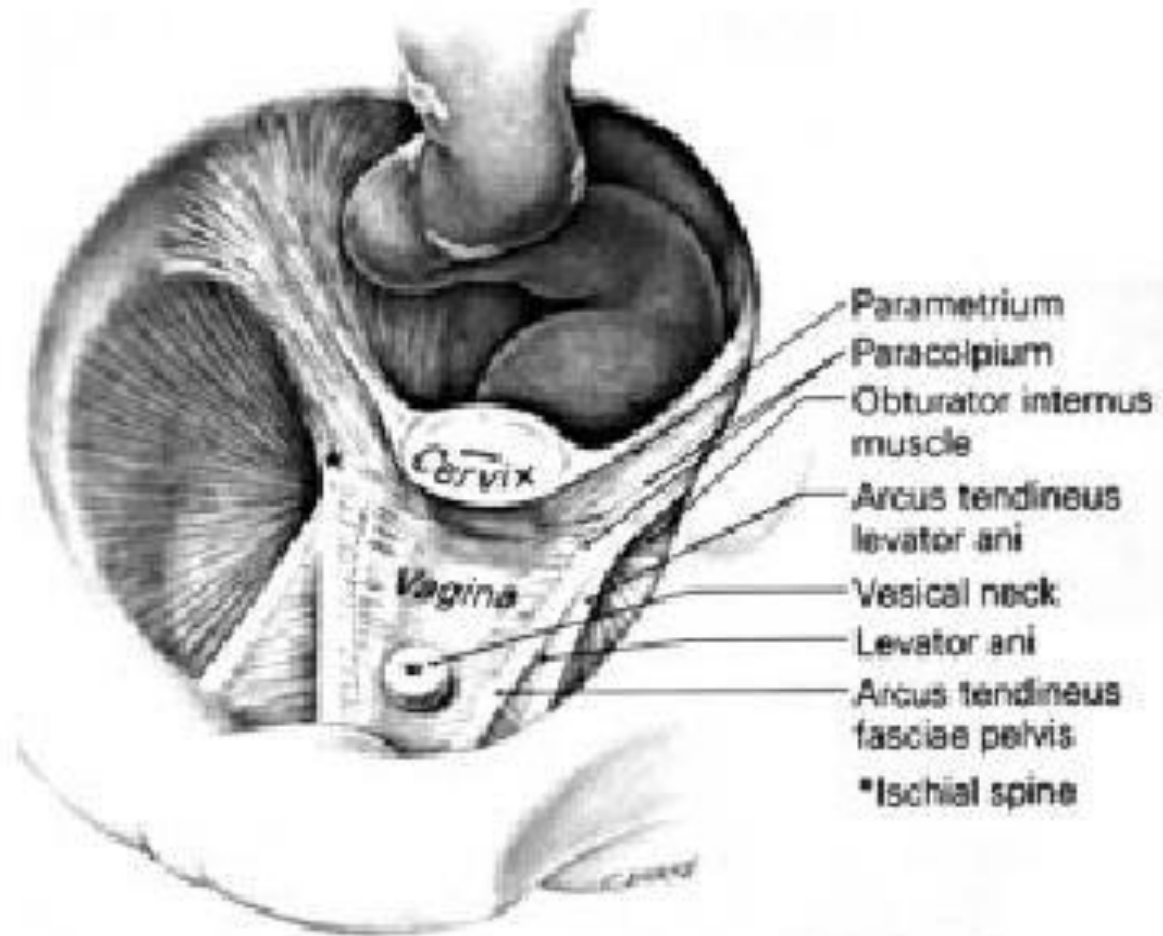
Diaphragme pelvien et Hiatus uro-génital



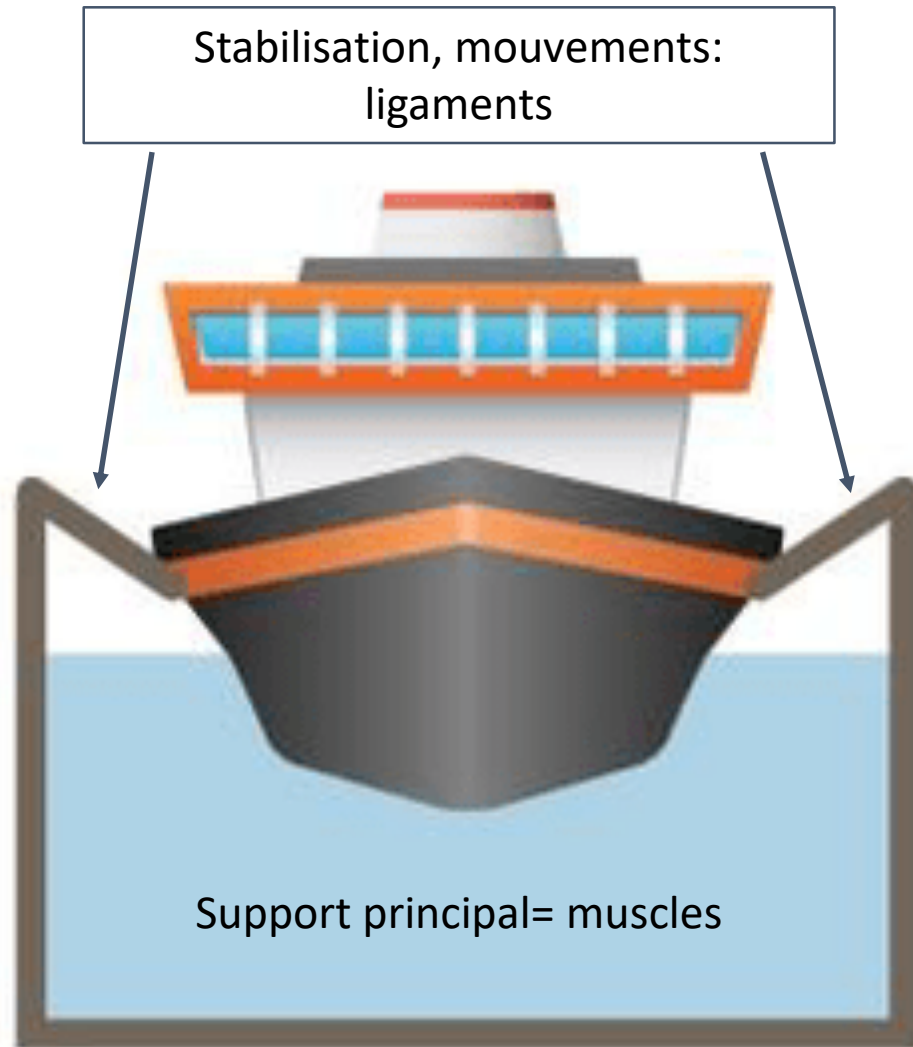
Support musculaire des organes pelviens: Releveurs de l'anus



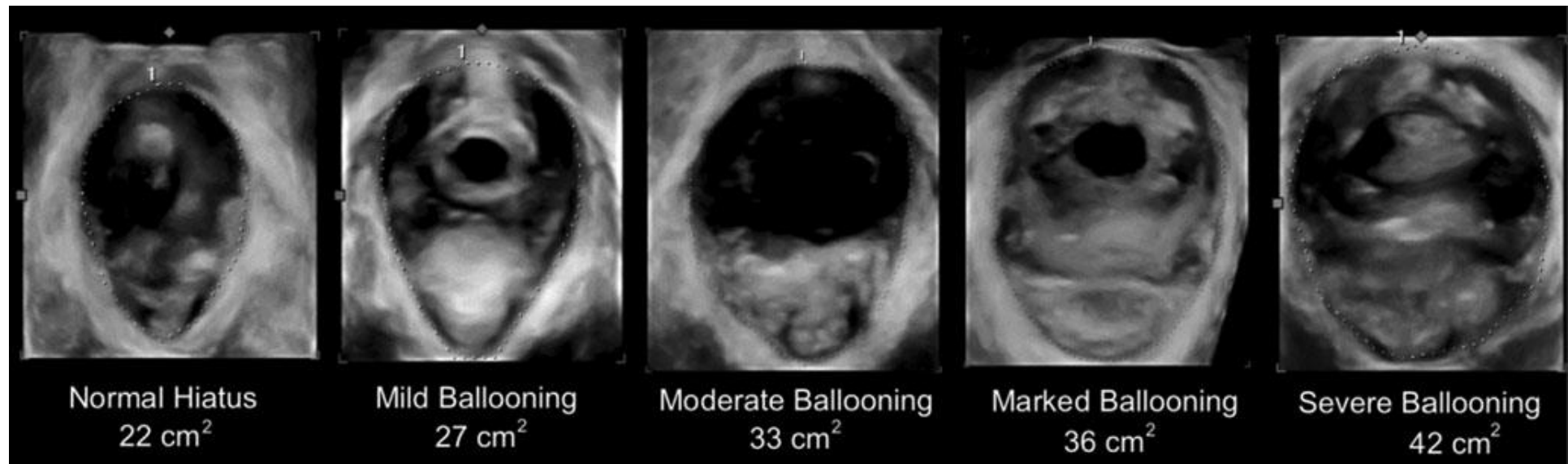
Fascia endopelvien: tissu conjonctif dense: fibres collagène et élastique



THE BOAT THEORY



« Ballooning »



Arrachement du m. pubo-rectal D

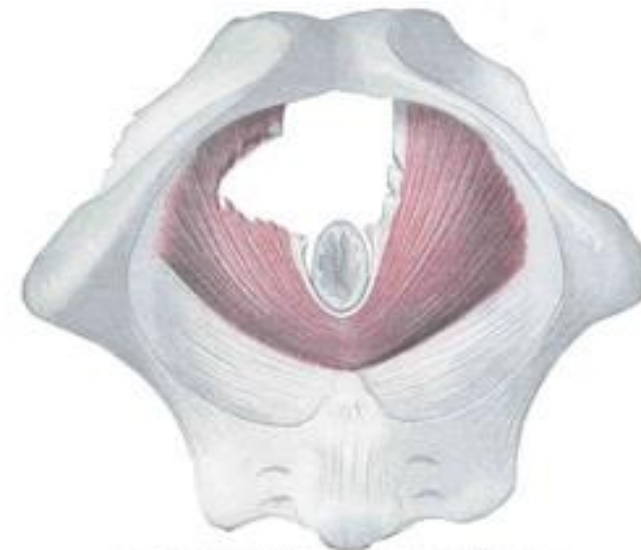


FIG. 261.—"Sphincterotomy." LACERATION OF THE LEVATOR ANI.
An injury to the anterior portion of the levator ani—the puborectal or pelvic—flat—its tearing between the blades
of the obstetric forceps and the rectum prolaps. (Very difficult to repair).
De Lee, Joseph B., A.M., M.D. The Principles and Practice of Obstetrics. 7th ed.
Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1938

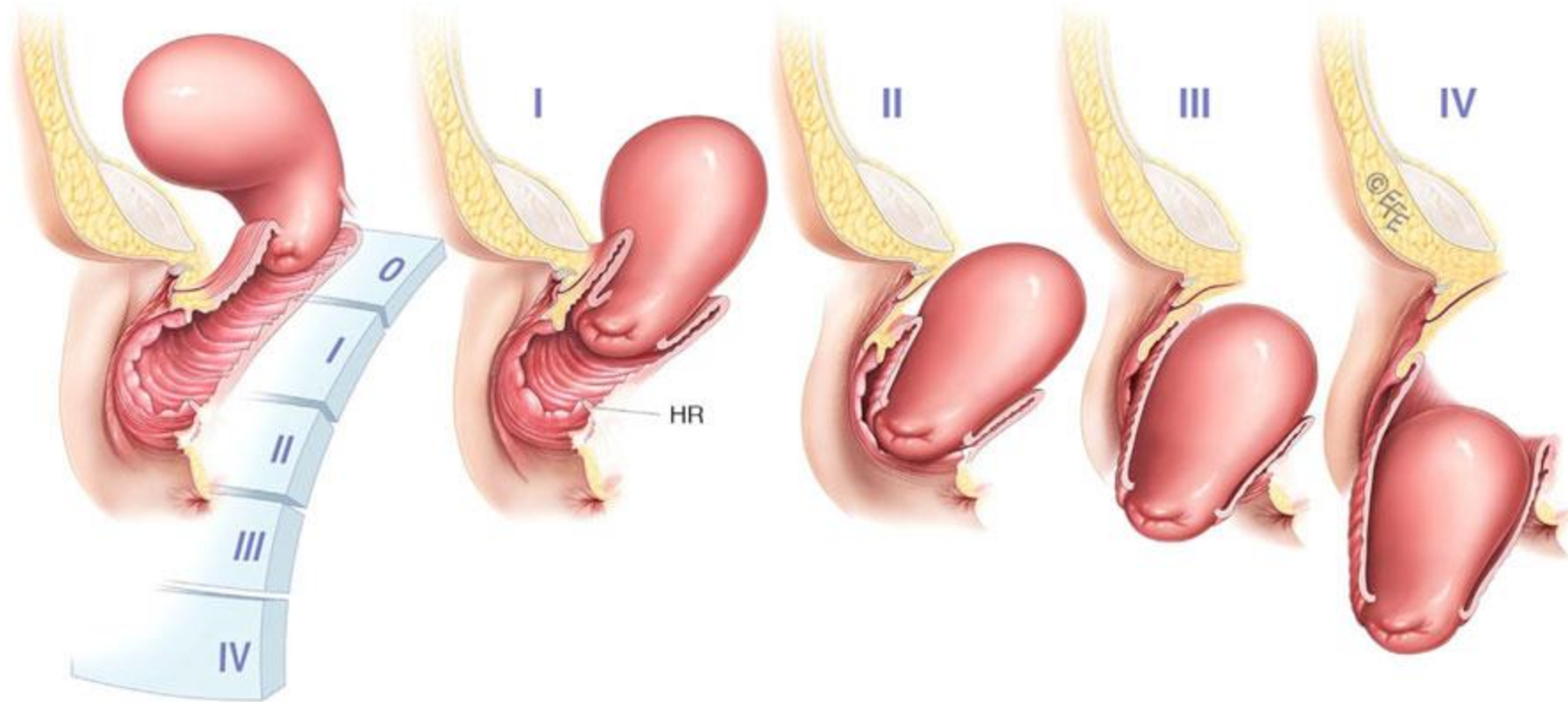


Cystocele
(Prolapsed bladder)



Rectocele
(Prolapsed rectum)

Staging prolapsus utérin



Examen clinique d'évaluation de la mobilité des trois compartiments vaginaux



Defects :
antérieurs
moyen
postérieur
éviscération



Prolapsus des 4 compartiments

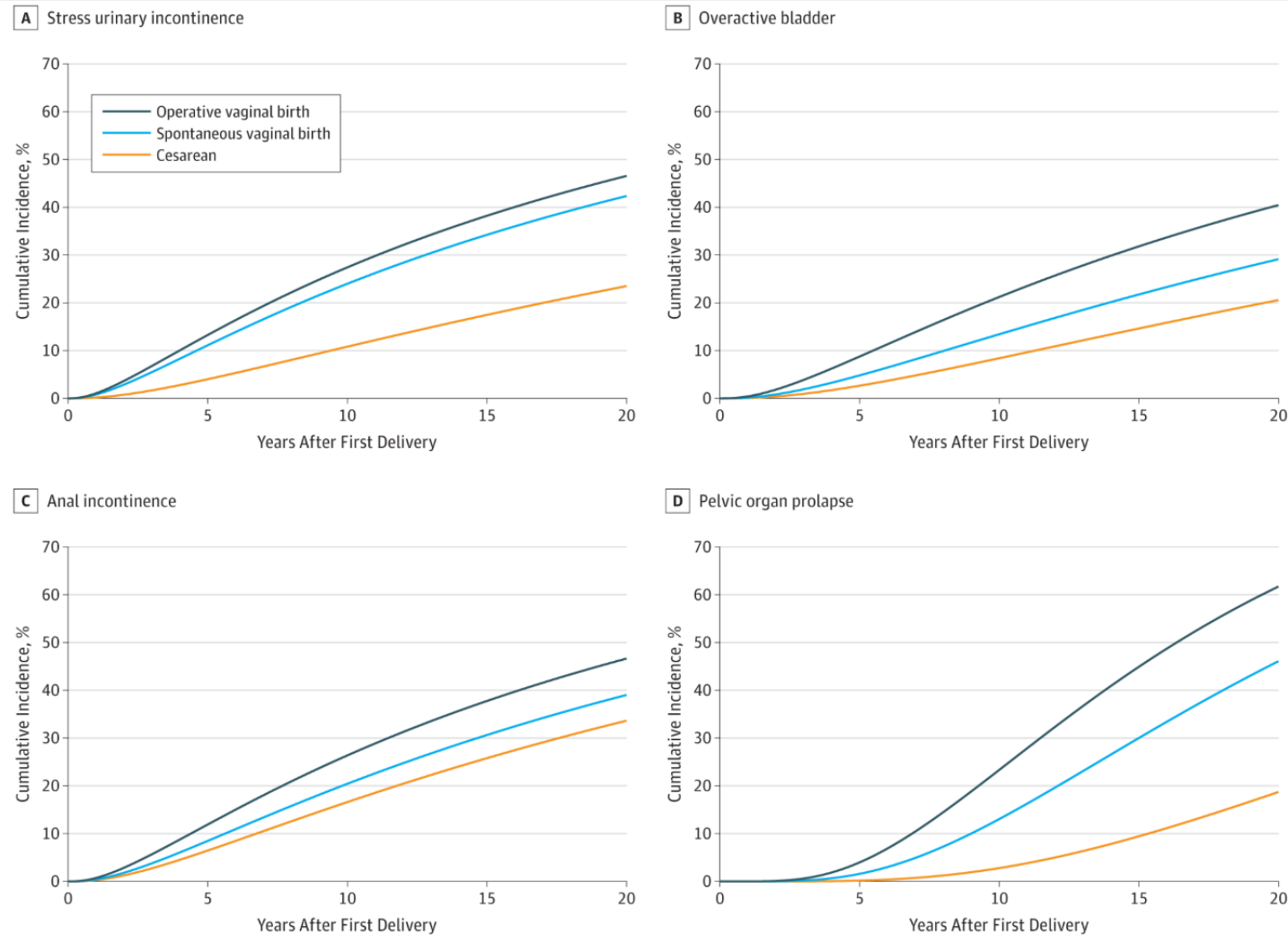


Symptômes

- Souvent asymptomatique
- Compartiment antérieur
 - Incontinence urinaire
 - Troubles de la miction, rétention urinaire
- Compartiment moyen
 - Pesanteur pelvienne, masse, « boule »
- Compartiment postérieur
 - Troubles de l'évacuation des selles
 - Souillures, incontinence selles

Causes: défaillance des structures de soutien

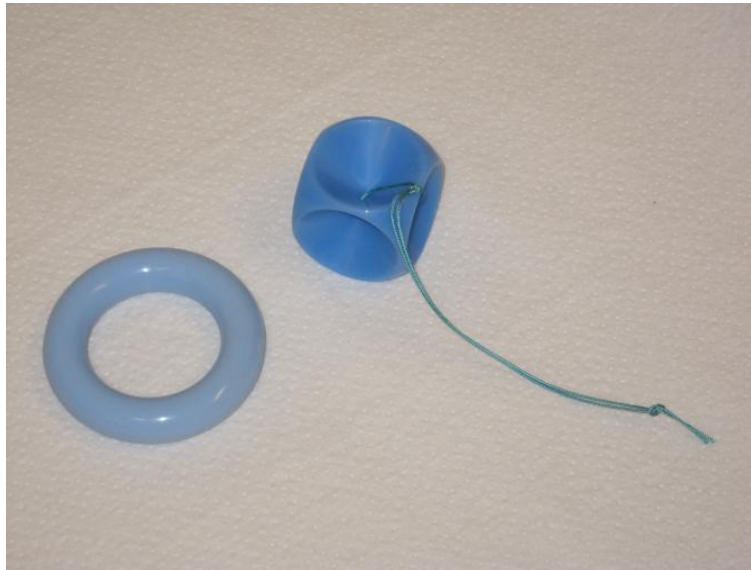
- « Traumatisme » obstétrical
 - Macrosomie, Accouchements instrumentés
- Ménopause, atrophie sénile
 - Perte tonicité et élasticité des tissus
- ATCD chirurgicaux
 - Traumatisme chirurgical
- Efforts répétés
 - Constipation, toux chronique, port de charges



Cumulative Incidence of Pelvic Floor Disorders by Delivery Mode

Traitement

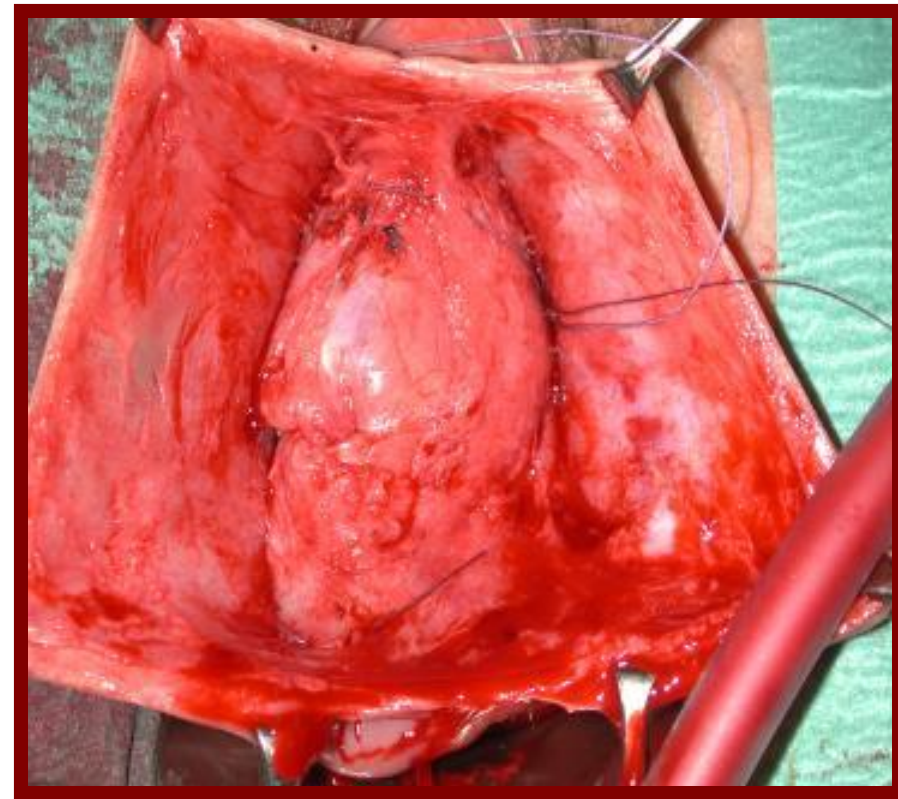
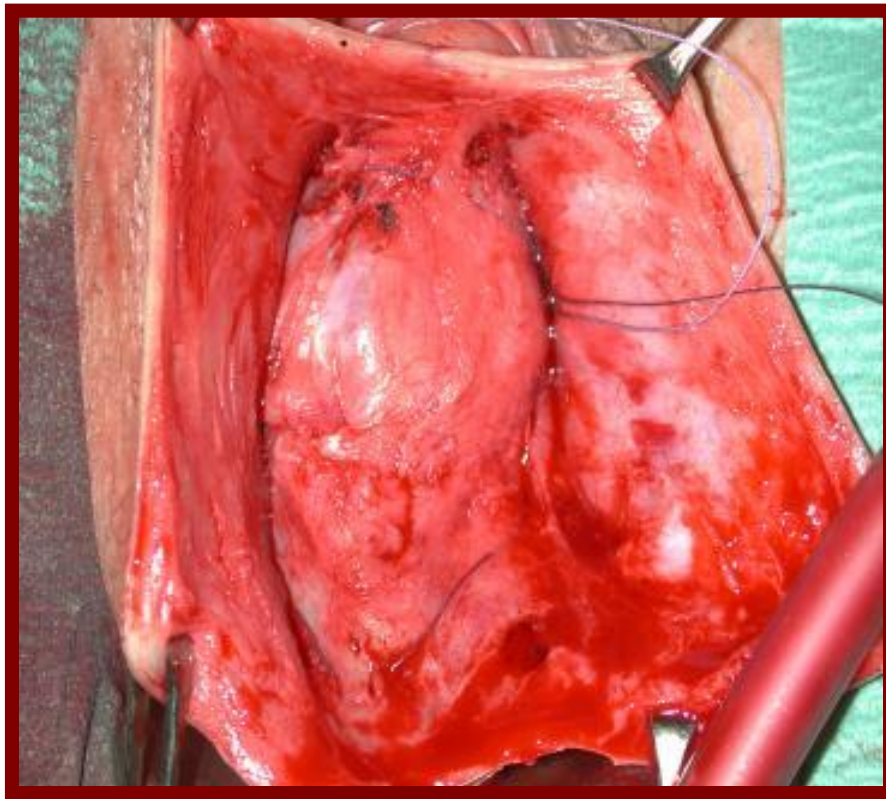
- Chirurgical
 - Colporraphie antérieure
 - Colpo-périnéorraphie postérieure
 - Suspension utérine ou dôme vaginal au ligament sacro-spinal ou au promontoire sacré
- Conservateur
 - Pessaire, cube



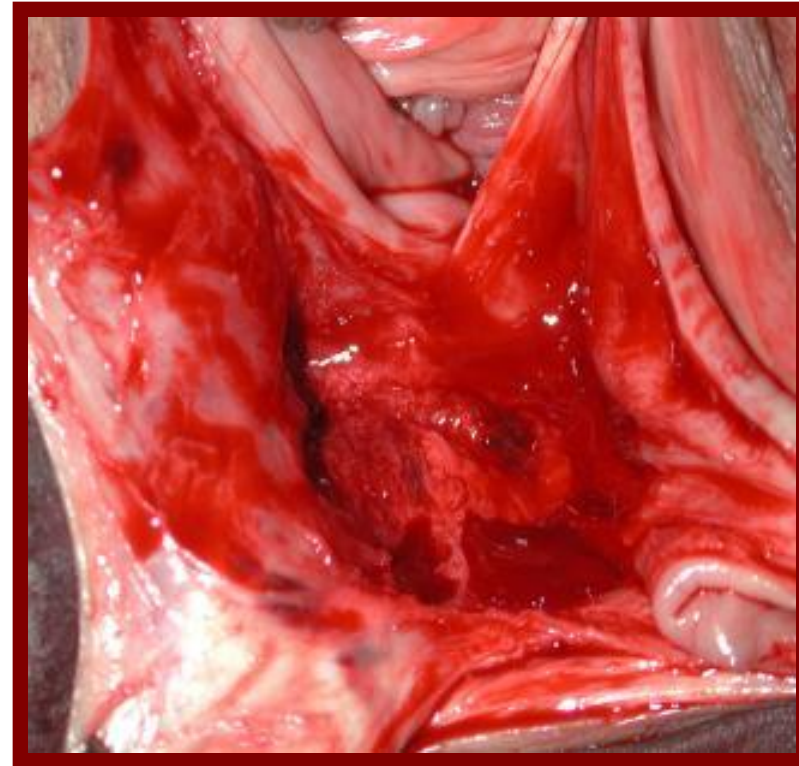
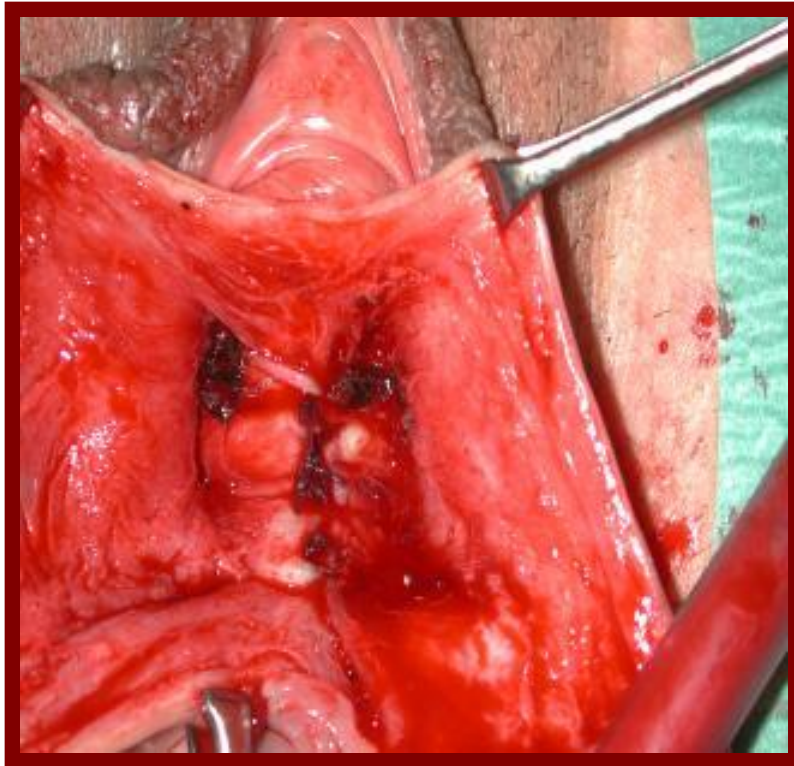
Traitement de la cystocèle: Colporrahie antérieure

Ouverture de la paroi vaginale antérieure

Dissection du fascia endopelvien antérieur



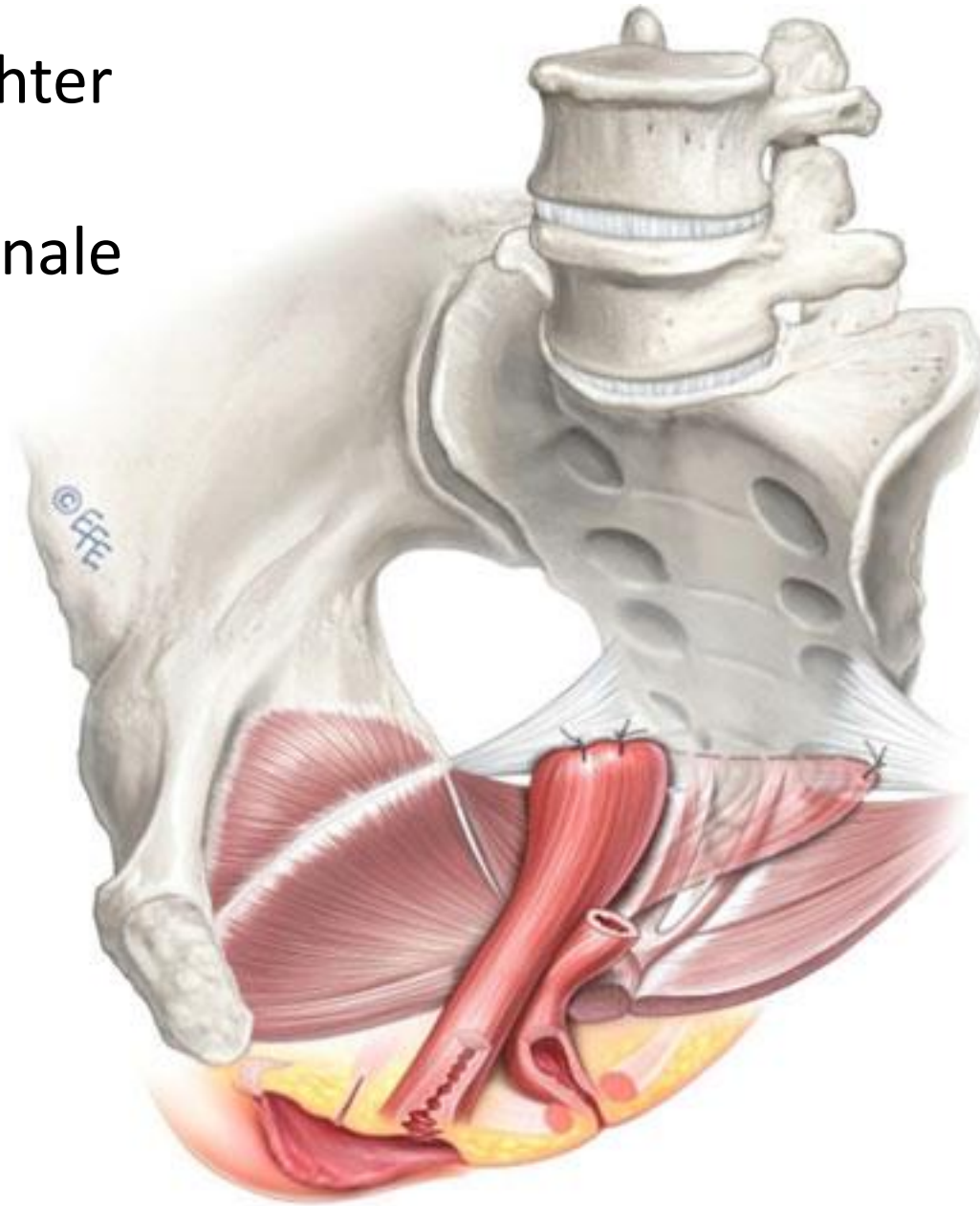
**Traitement de la cystocèle: Colporraphie
antérieure: suture et mise en tension du fascia
endopelvien antérieur
Récidive 10-15%**



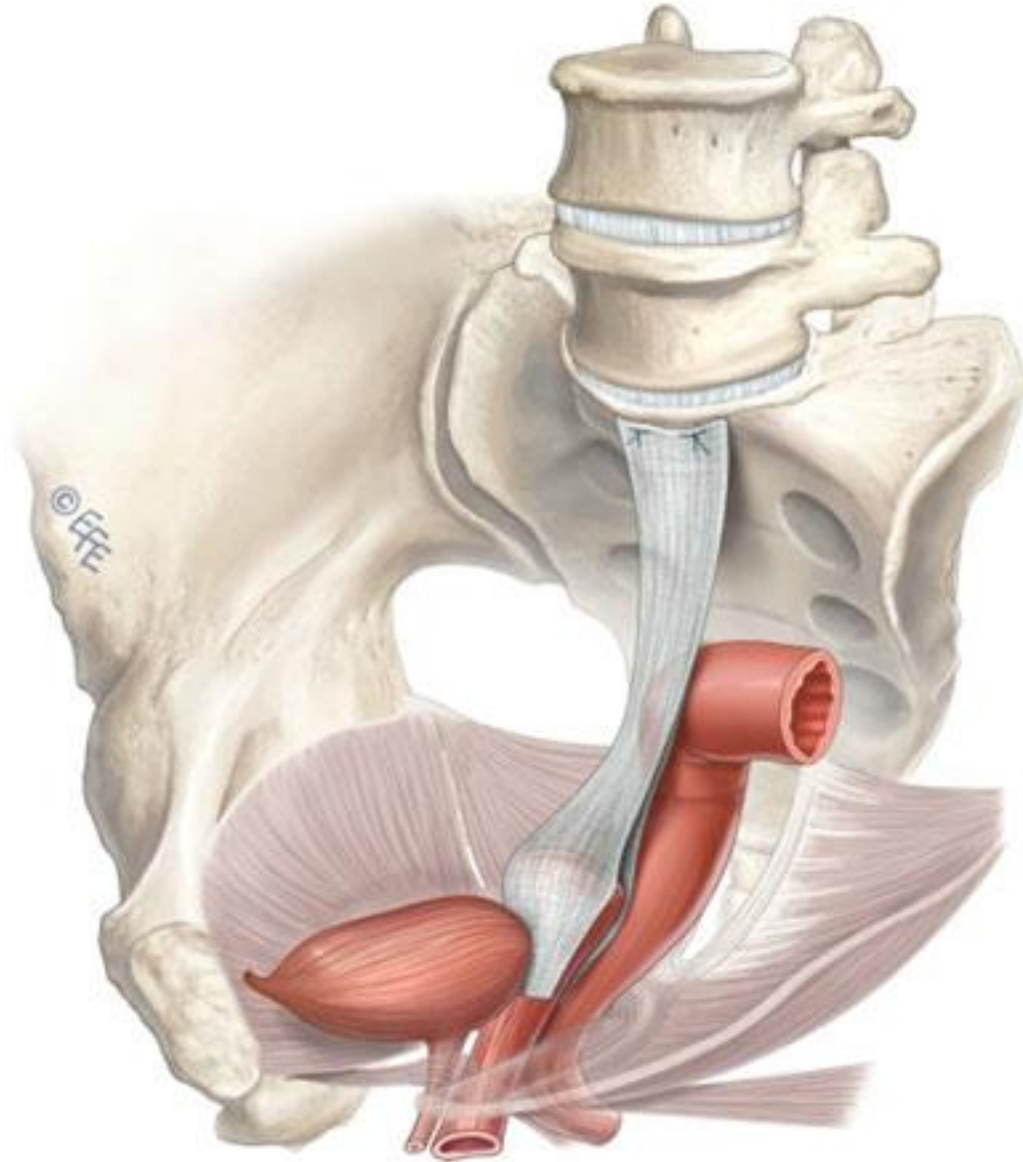
Filet synthétique par voie trans-vaginale



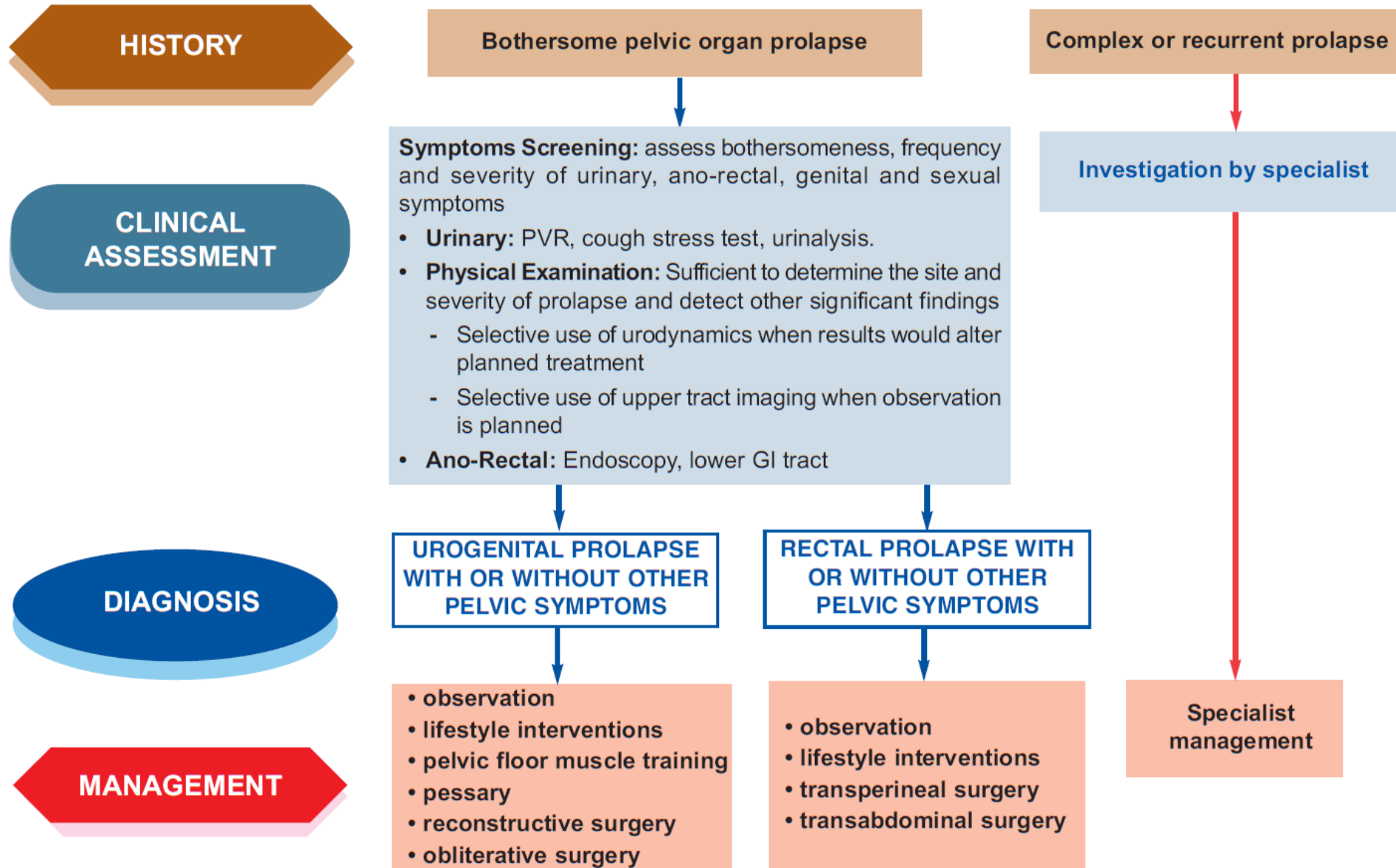
Opération de Richter
ou
Fixation sacro-spinale



Promontofixation ou Sacrocolpopexie



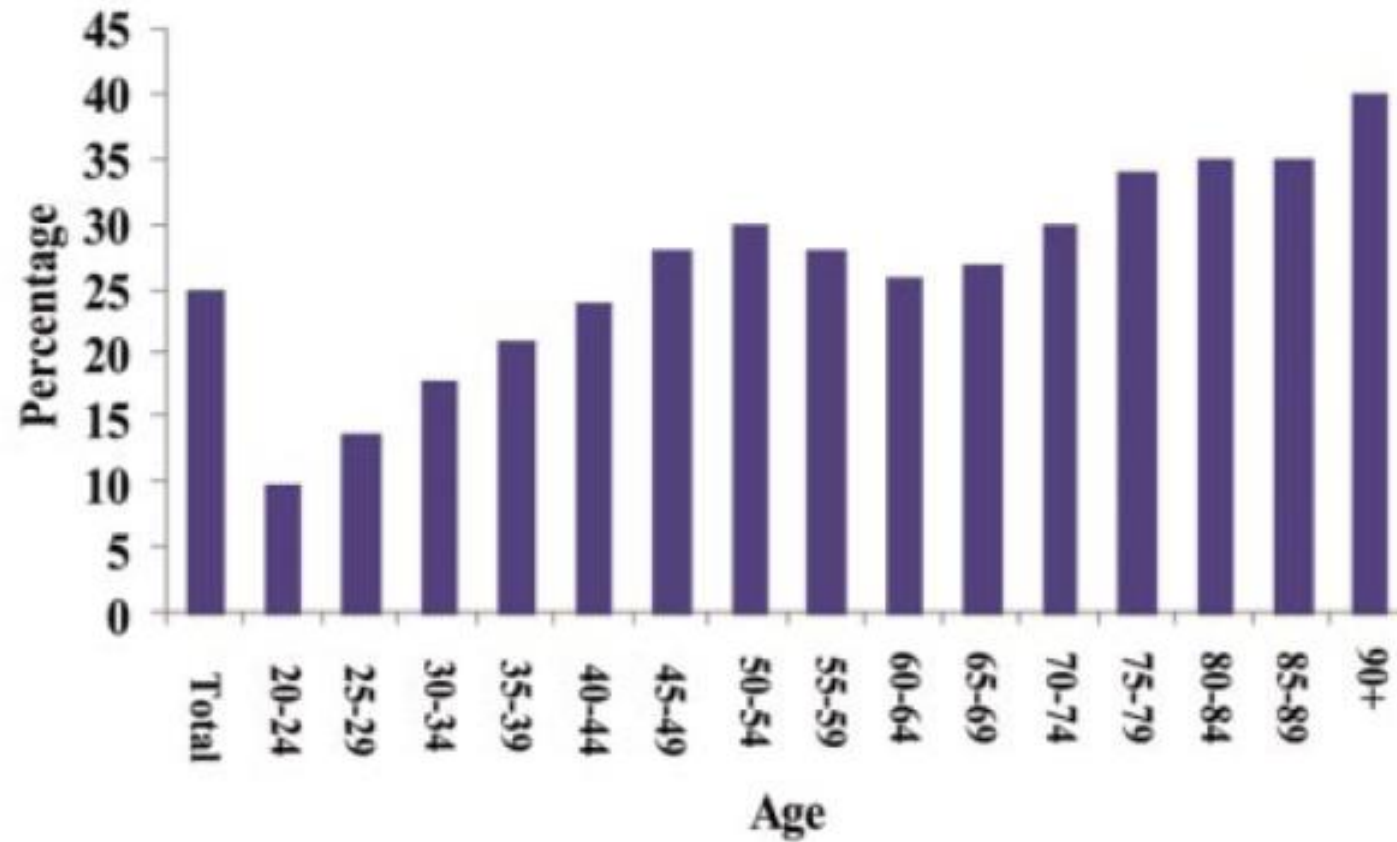
Management of Pelvic Organ Prolapse (including urogenital prolapse, and recta prolapse)



Incontinence urinaire

« Une condition où la perte involontaire d'urine pose un problème social ou d'hygiène et est objectivement démontrable »

Prévalence de l'Incontinence Urinaire



Cycle de la miction

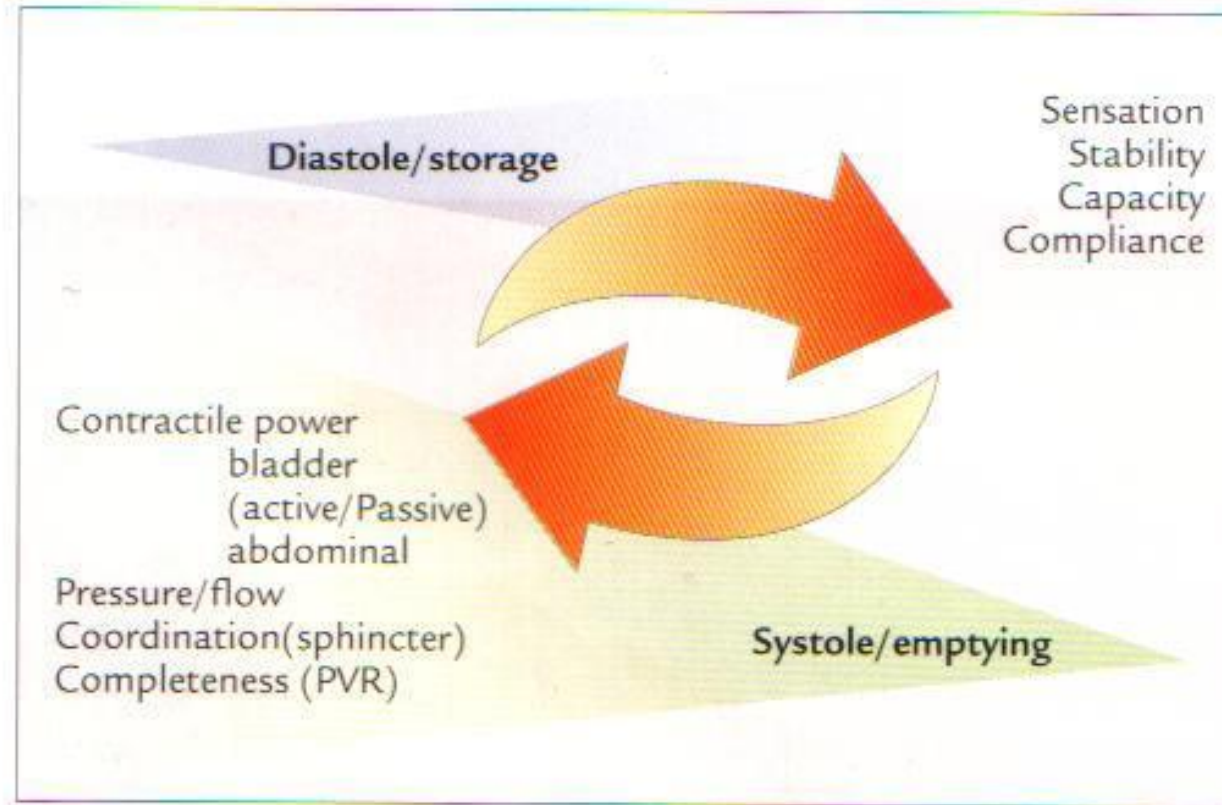
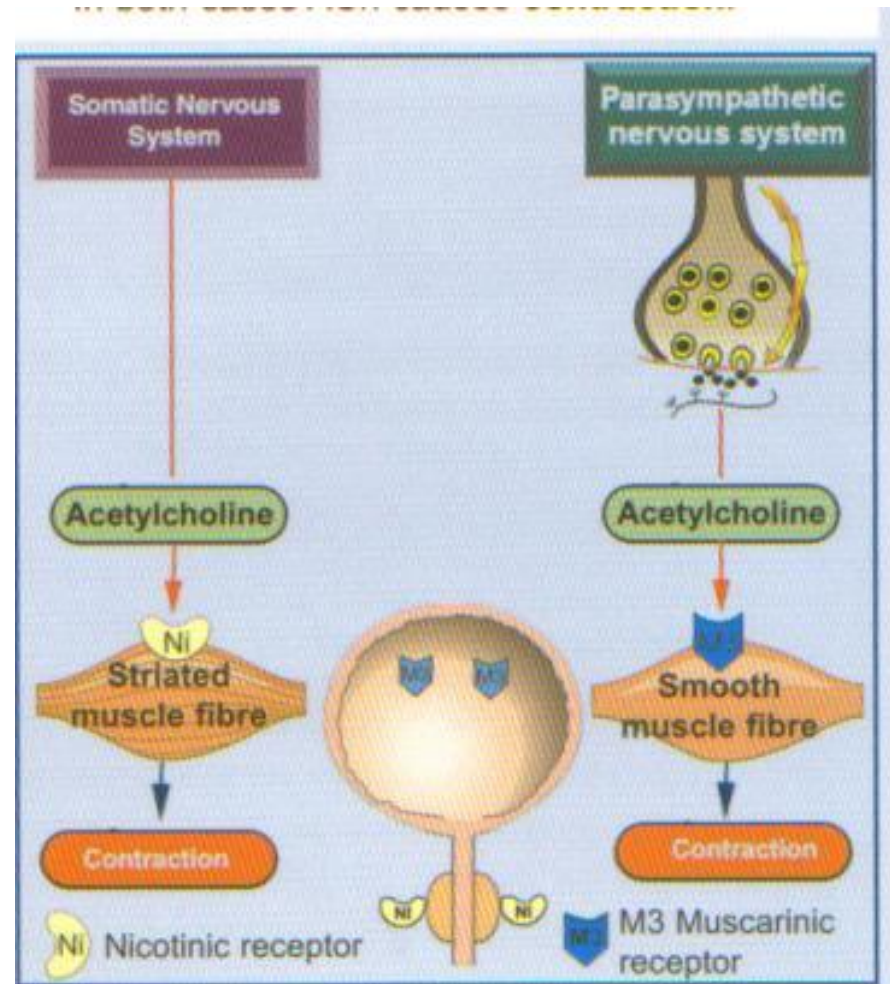


Figure 12.1. *The bladder cycle incorporates all major elements of bladder function and continence into a continuous conceptual whole. PVR, post-void residual.*

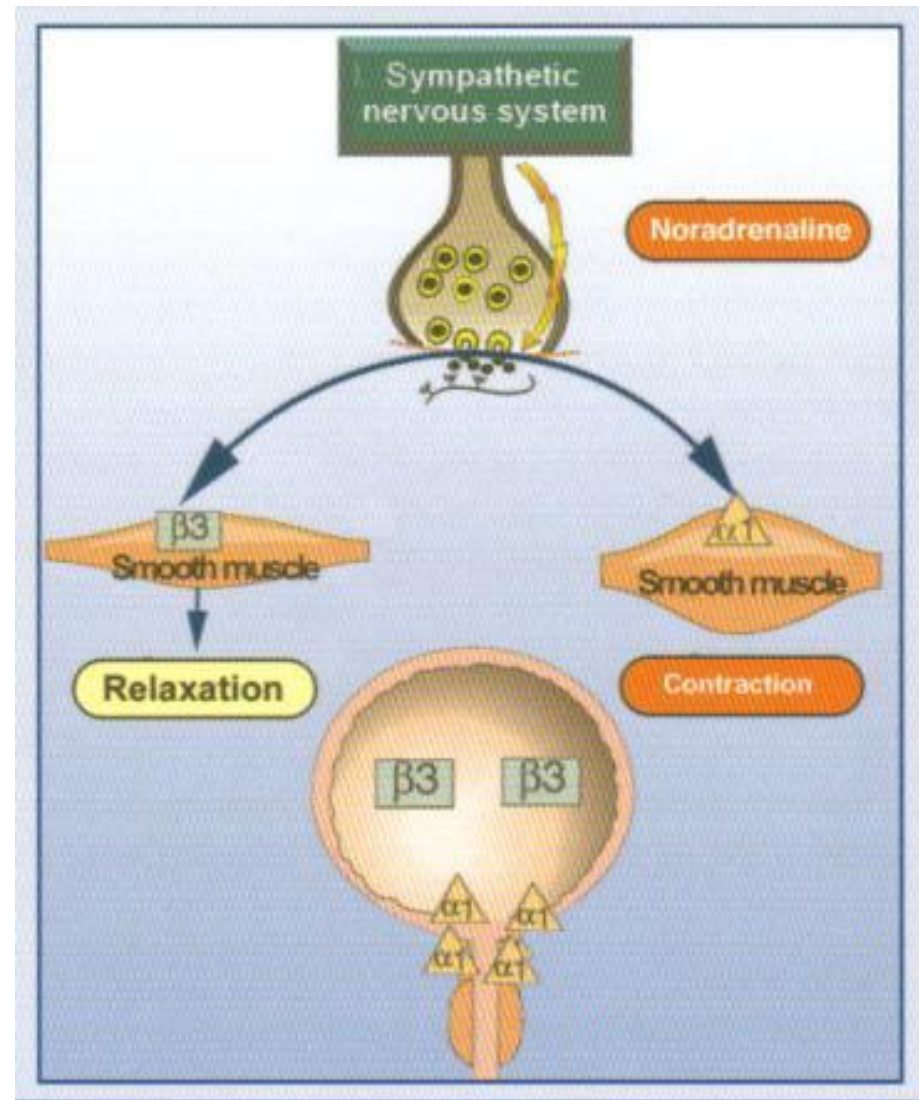
Systeme nerveux parasympathique

Acetylcholine

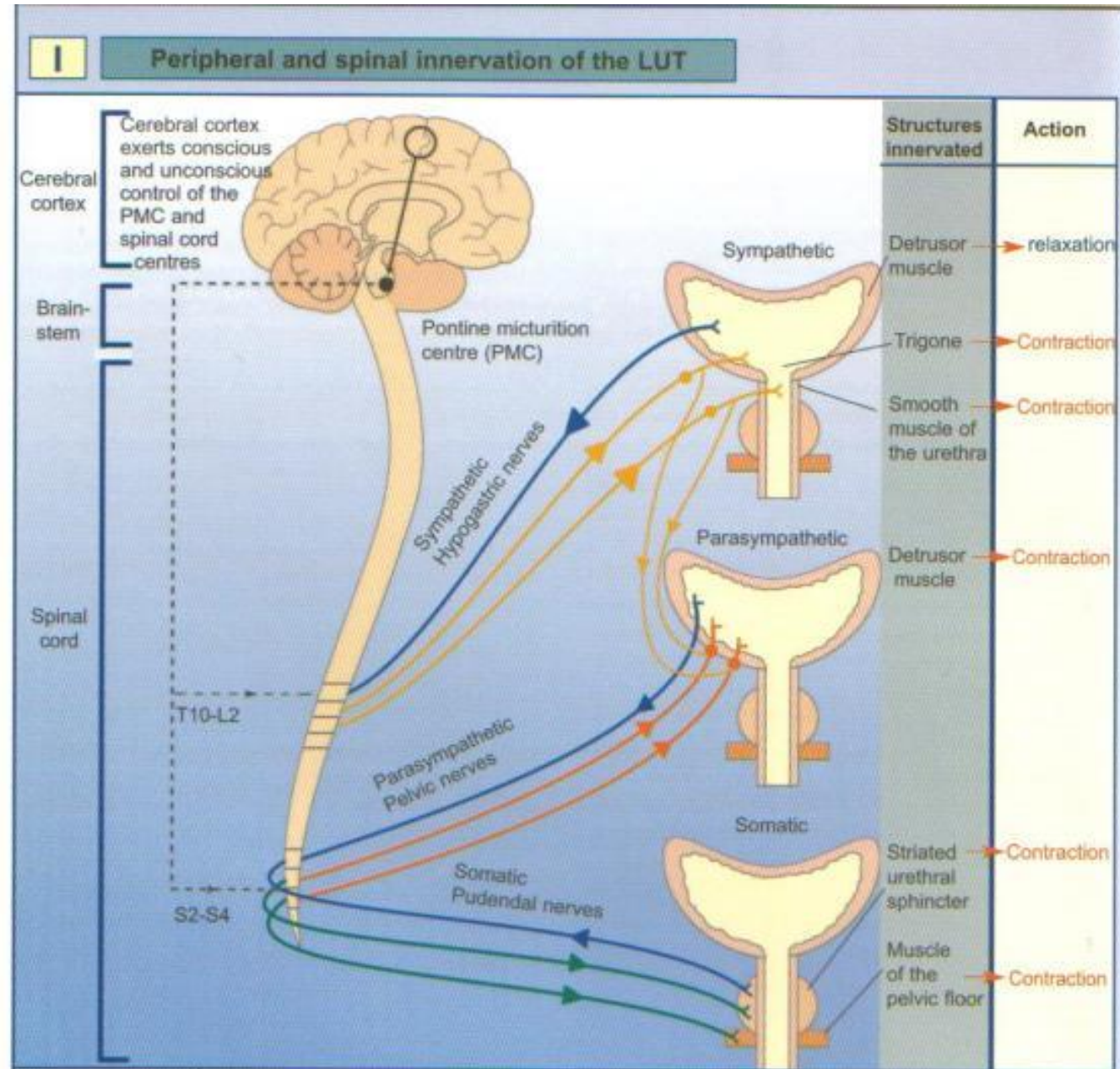


Système nerveux sympathique

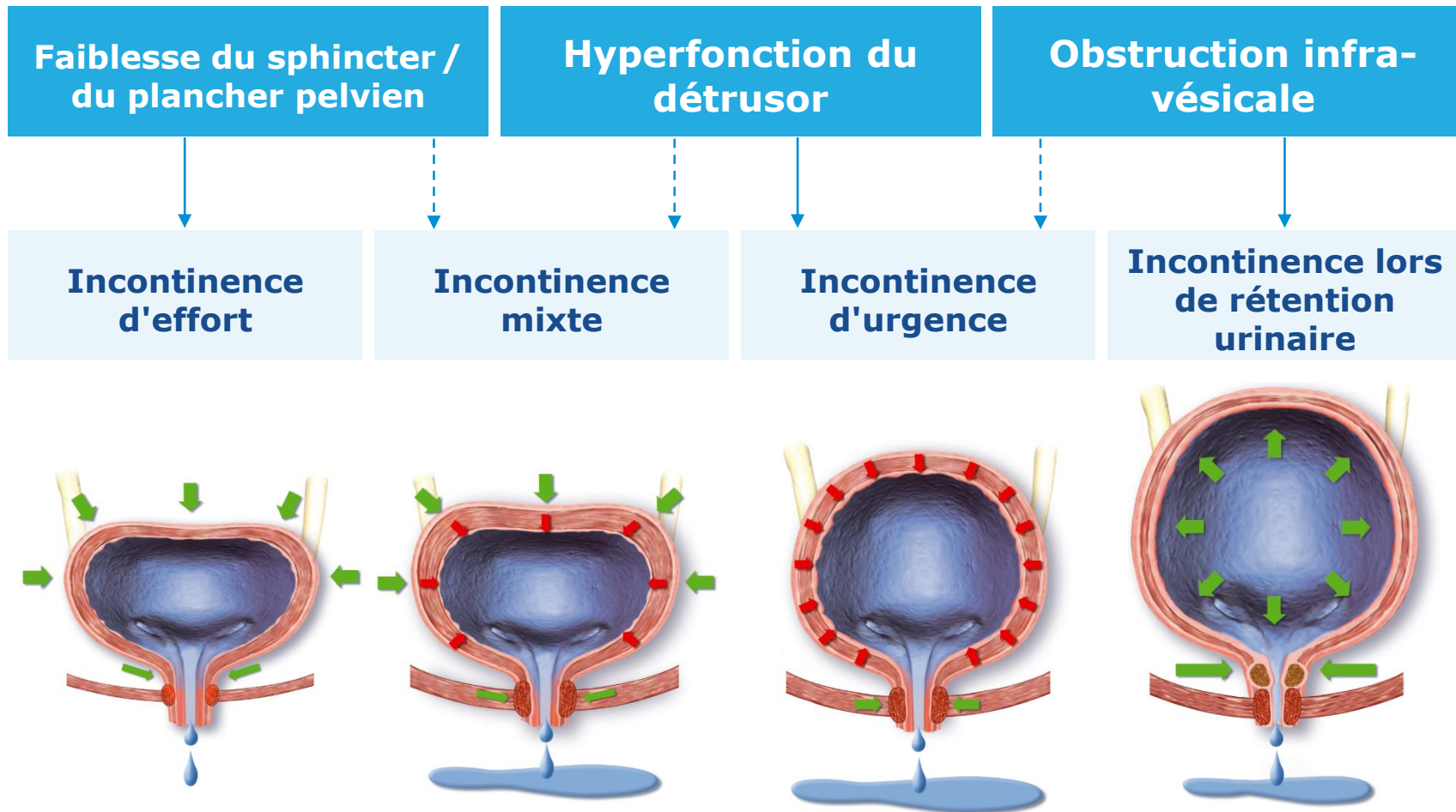
Noradrénaline



Contrôle de la vessie



Les formes d'incontinence les plus fréquentes



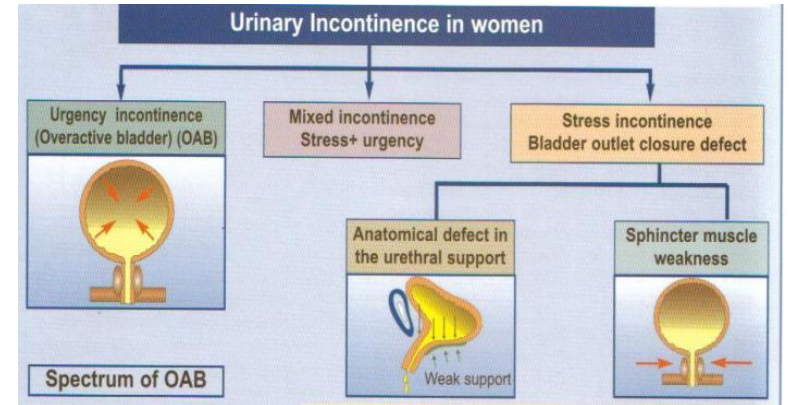
Facteurs de risques

- Age
- Grossesse
- Accouchement
- Ménopause
- Hystérectomie
- Obésité
- Atteinte fonctionnelle
- Atteinte cognitive
- Risques liés aux activités
- Histoire familiale et génétique

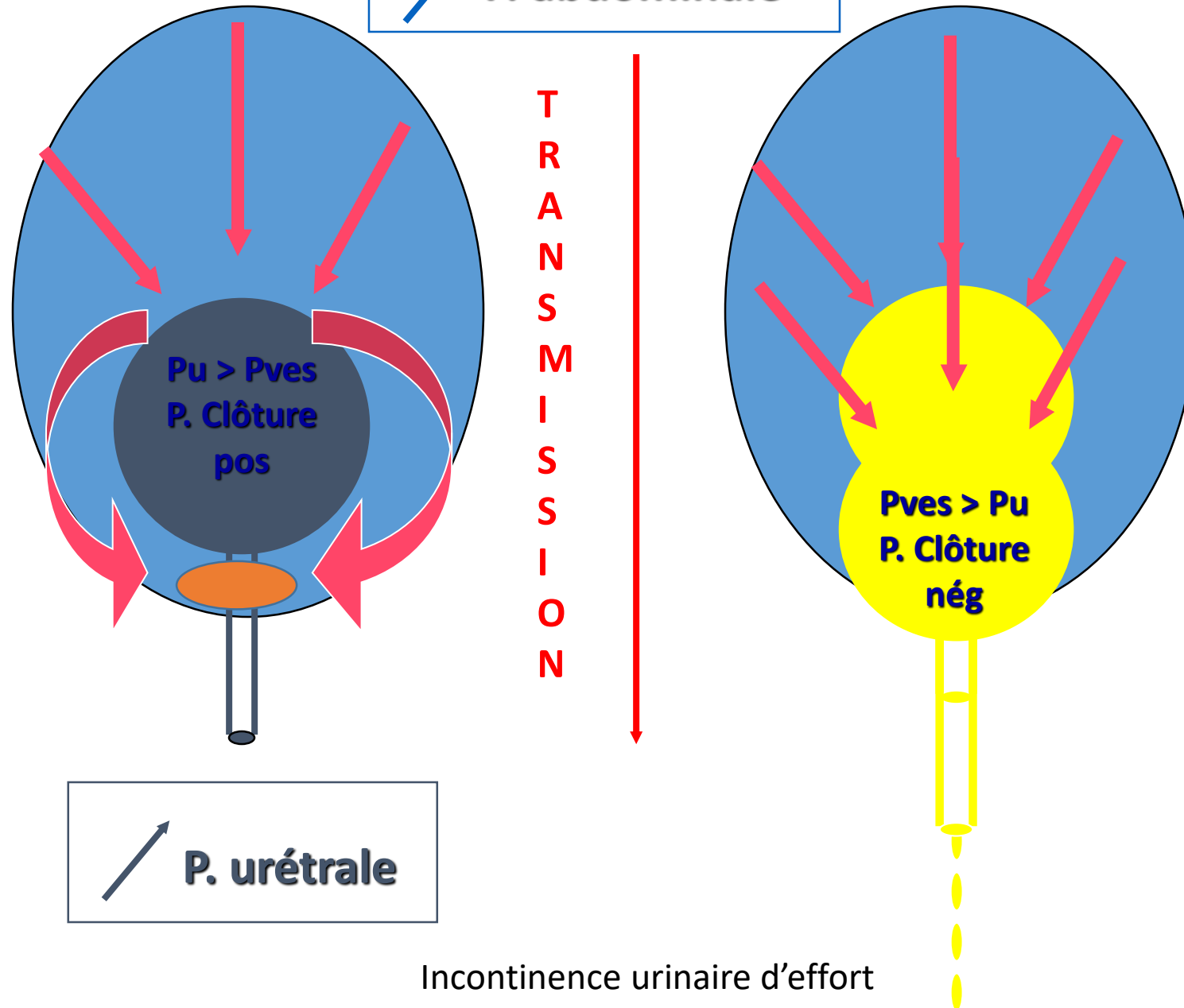
Incontinence urinaire d'effort= de « stress »

- Symptôme: perte involontaire d'urine survenant à l'effort (toux, éternuement, port de charge...)
- Signe: constat objectif de perte urinaire lors d'un effort
- Condition (urodynamique): perte d'urine à l'effort en l'absence de contraction du detrusor (cystométrie)

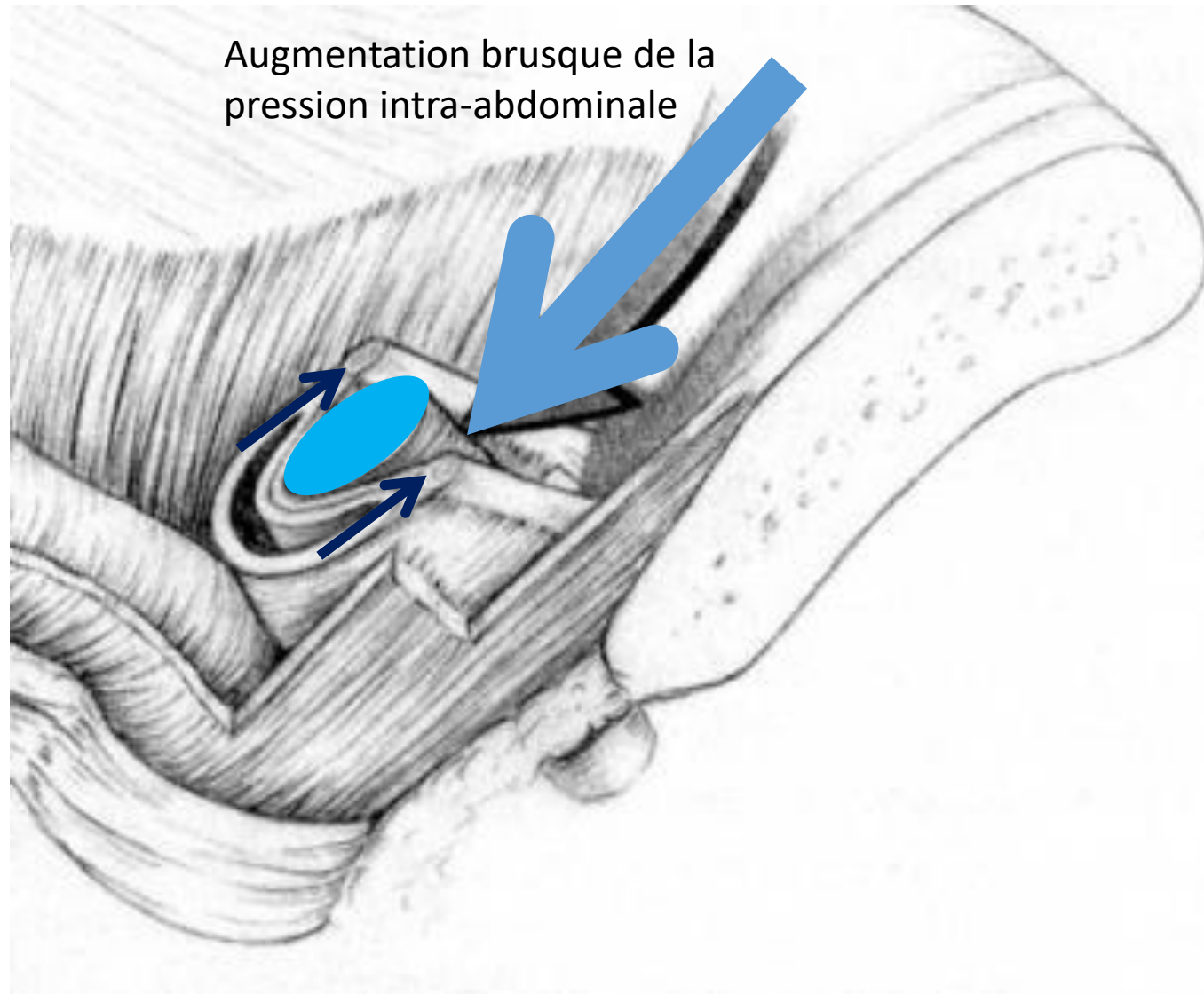
Causes

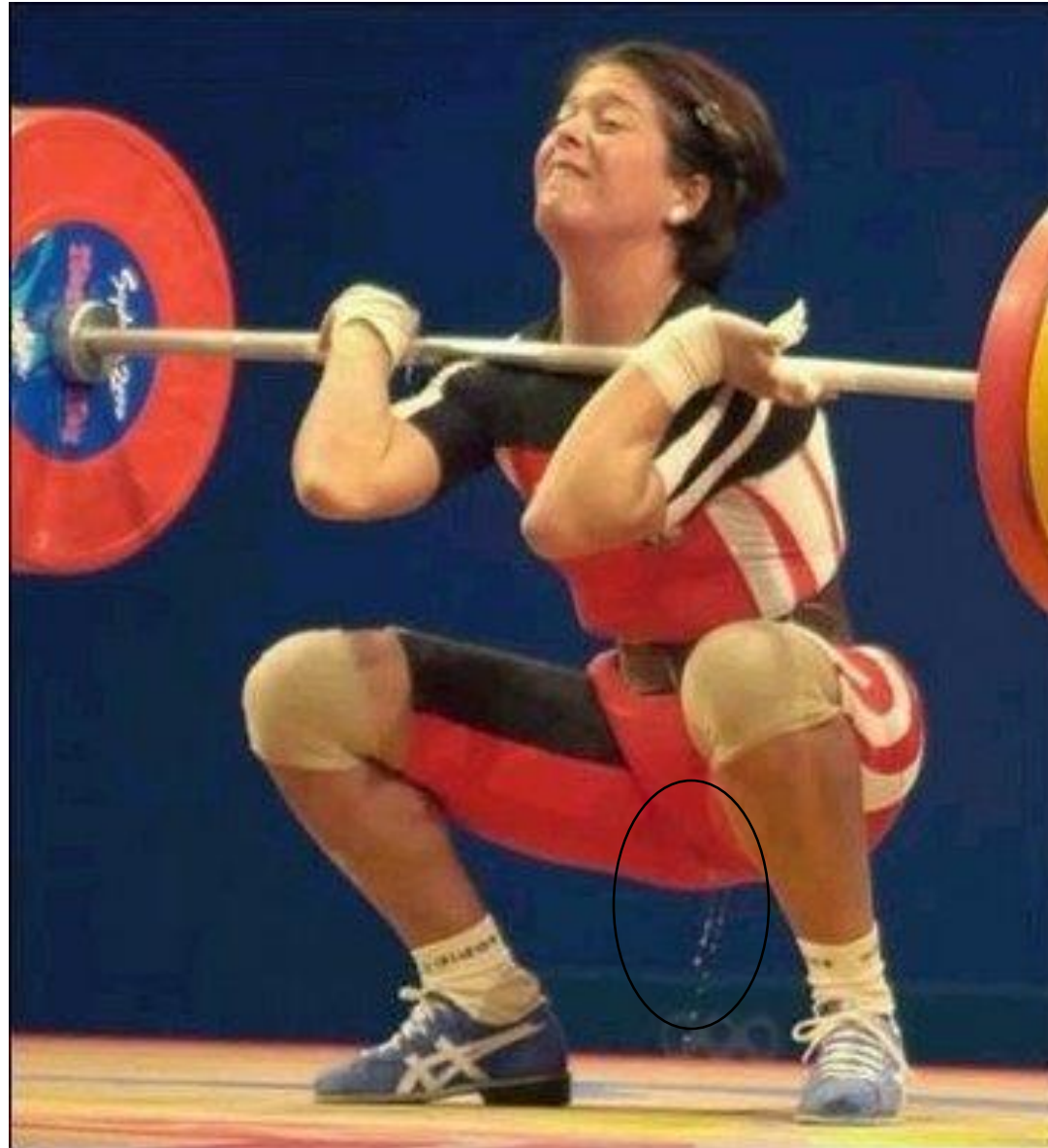


- Hypermobilité du col vésical: Q-tips test, périnéosonographie
- « Urètre à basse pression »: pression urétrale inférieure à 20 cmH₂O à la sphinctérométrie

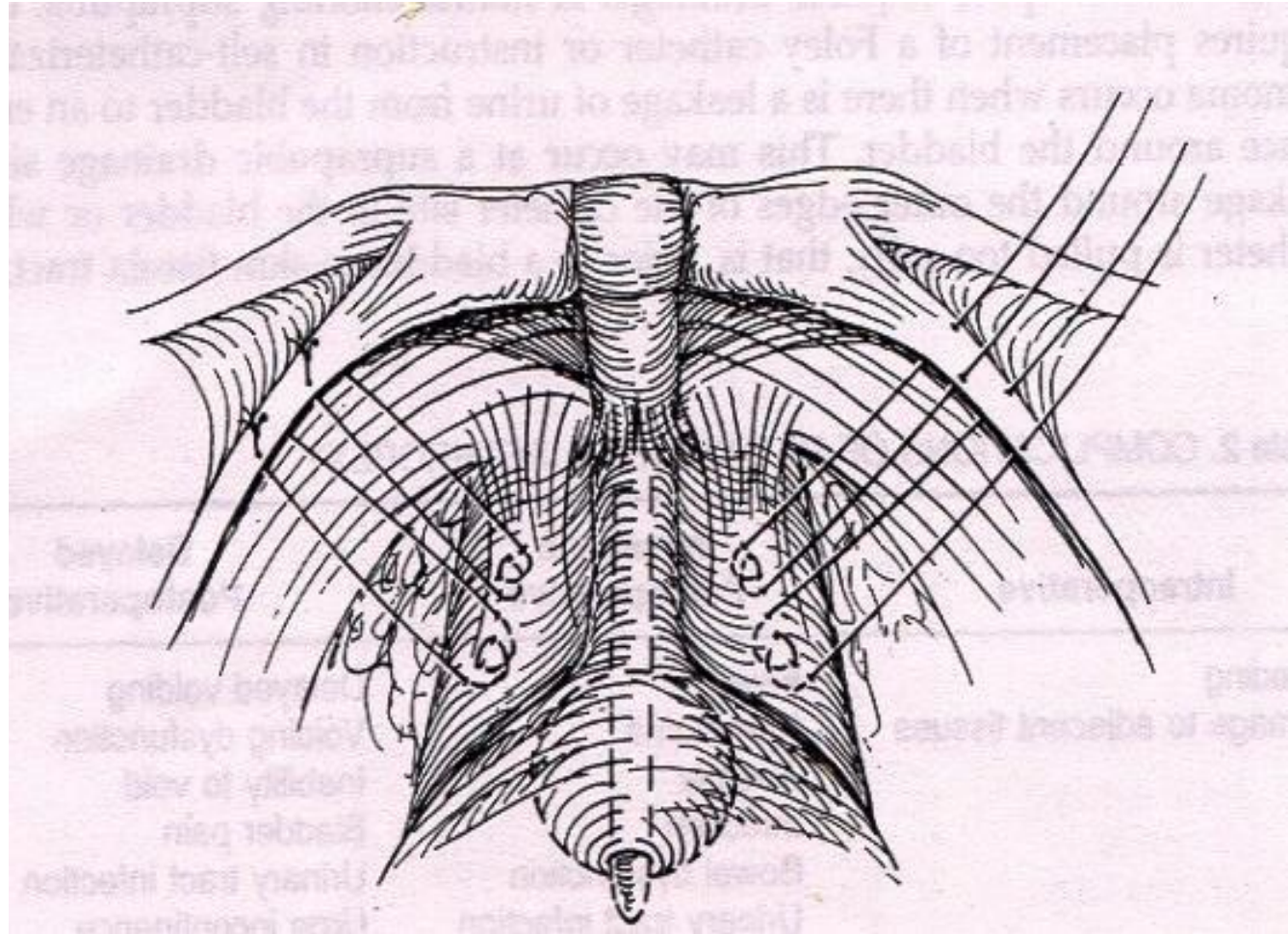


Physiopathologie

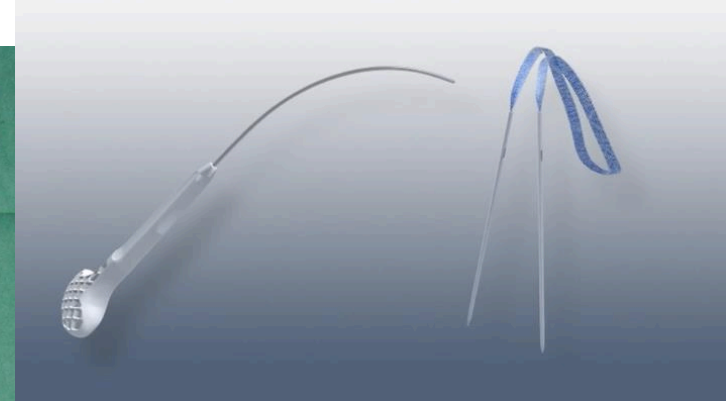
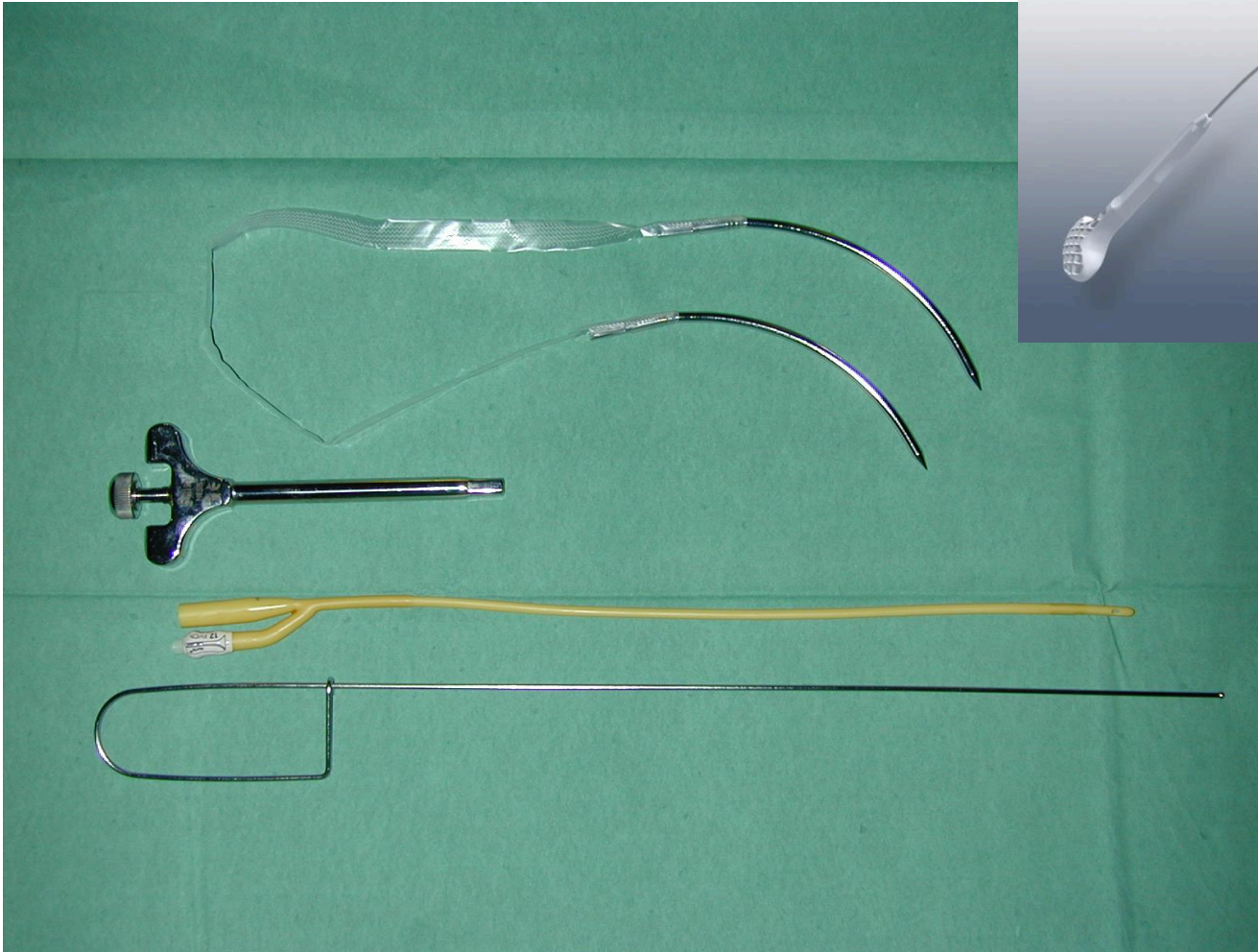


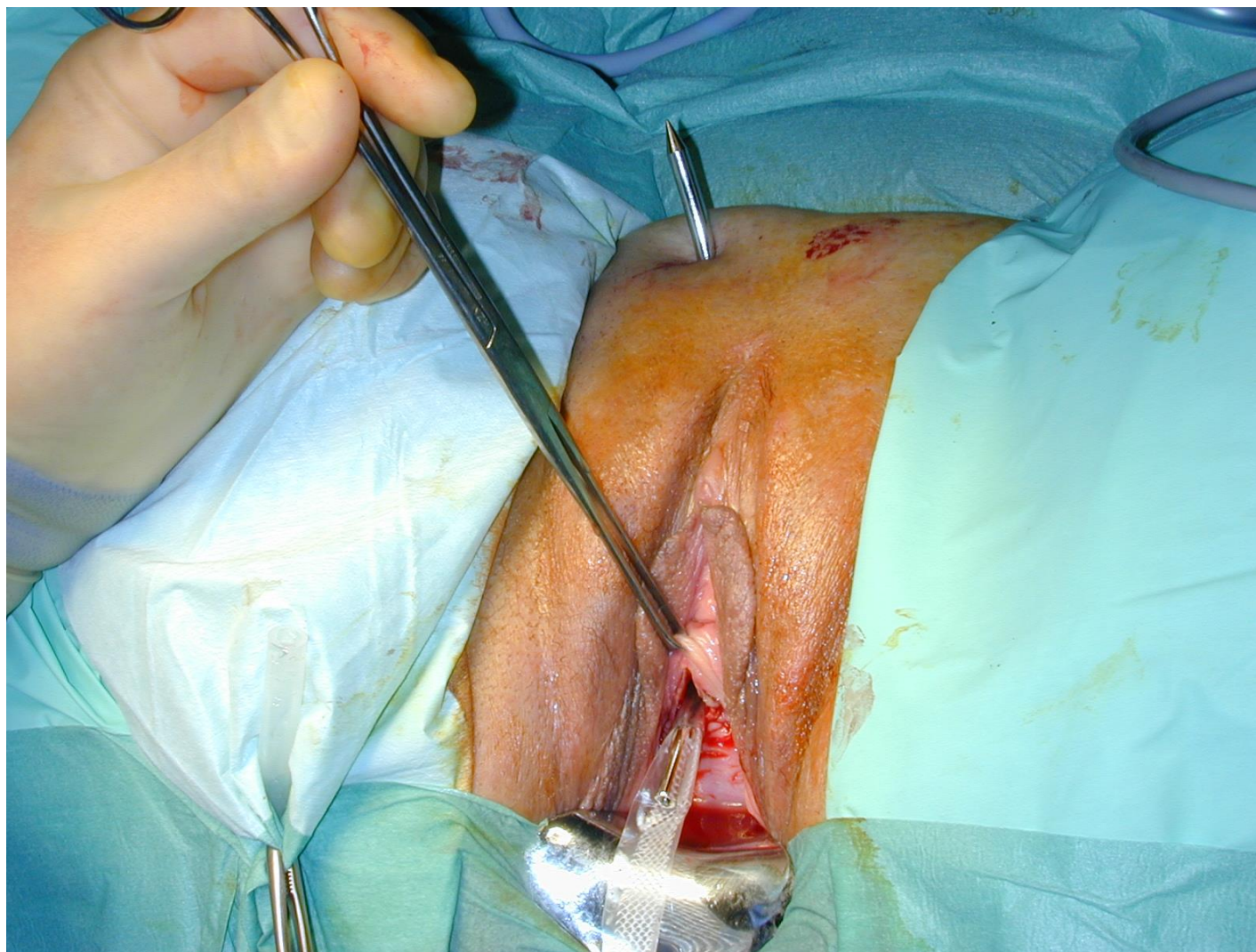


Burch colposuspension



Tensionfree vaginal tape TVT



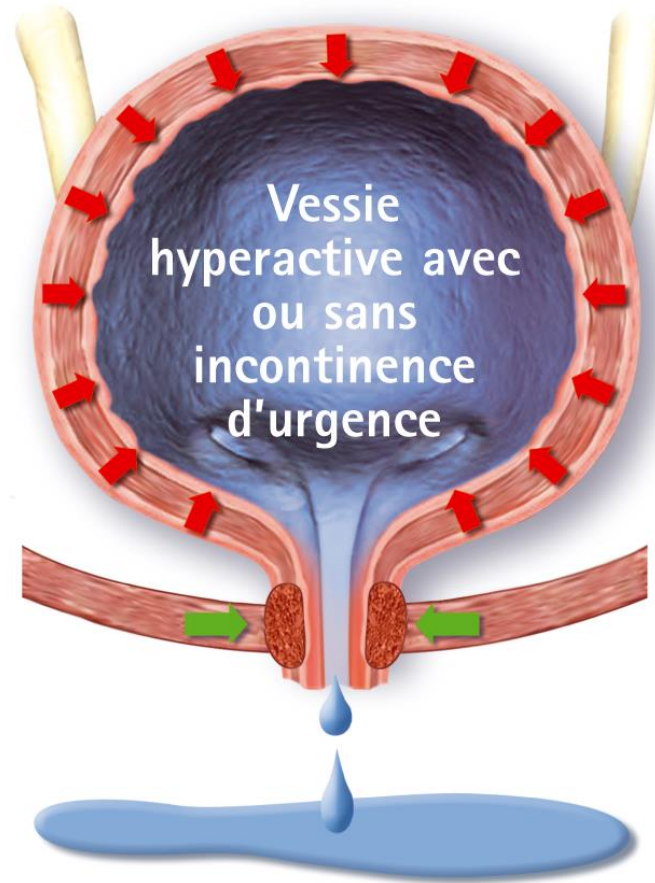


Incontinence urinaire complexe

Incontinence urinaire d'urgence

- **Urgence:** besoin soudain et violent d'uriner qui est inapproprié et qui, s'il n'est pas soulagé, peut résulter en pertes d'urine.
- **IUU:** Perte urinaire involontaire survenant immédiatement après une sensation d'urgence
- **Vessie hyperactive:** urgence, fréquence ($\geq 8x/24h$), nycturie

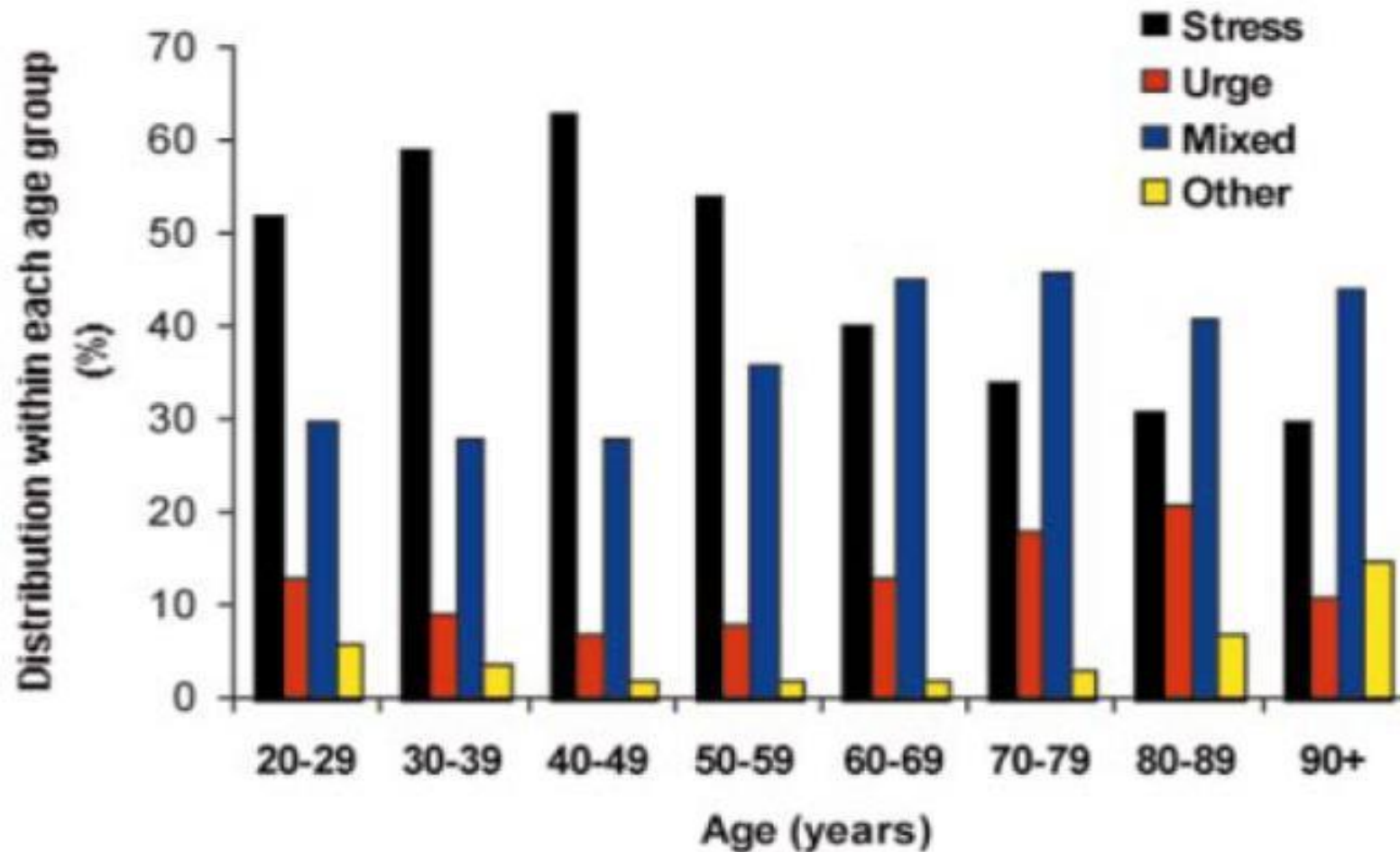
Vessie hyperactive



Diagnostic différentiel

- 90% des cas: «idiopathique»
- Pathologies neurologiques
 - Sclérose en plaques, Parkinson, AVC...
- Pathologies métaboliques
 - Diabète, diabète insipide, potomanie...
- Autres:
 - Infection, corps étranger...

Distribution des différents types d'IU



Traitements disponibles

- Mesures comportementales
 - Modification des habitudes de vie: perte pondérale, arrêt tabac...
 - Physiothérapie: rééducation vésicale, stimulation du n. tibial post.
- Traitements médicamenteux
 - Oestrogènes locaux
 - Anti-cholinergiques muscariniques: tolterodine, darifenacine...
 - Agonistes β -3: mirabegron
- Chirurgie
 - Toxine Botulique
 - Neurostimulation sacrée

Rééducation vésicale

Les buts de la rééducation vésicale sont

- de corriger les mauvaises habitudes de mictions fréquentes
- d'améliorer le contrôle des urgences mictionnelles de prolonger les intervalles entre les mictions
- d'augmenter la capacité vésicale
- de réduire les épisodes d'incontinence
- de restaurer la confiance du patient dans sa capacité à contrôler sa vessie.

Rééducation

- Physiothérapie
- Calendrier mictionnel
- Conseils diététiques
- Questionnaires de qualité de vie

[illegible]

Médicaments

❑ Anti-cholinergiques:

I gén. { • Chlorure de Trospium (Spasmo-Urgenin Neo[®])
• Flavoxate (Urispas[®])
• Oxybutynin (Ditropan[®], Lyrinel[®], Kentera[®])

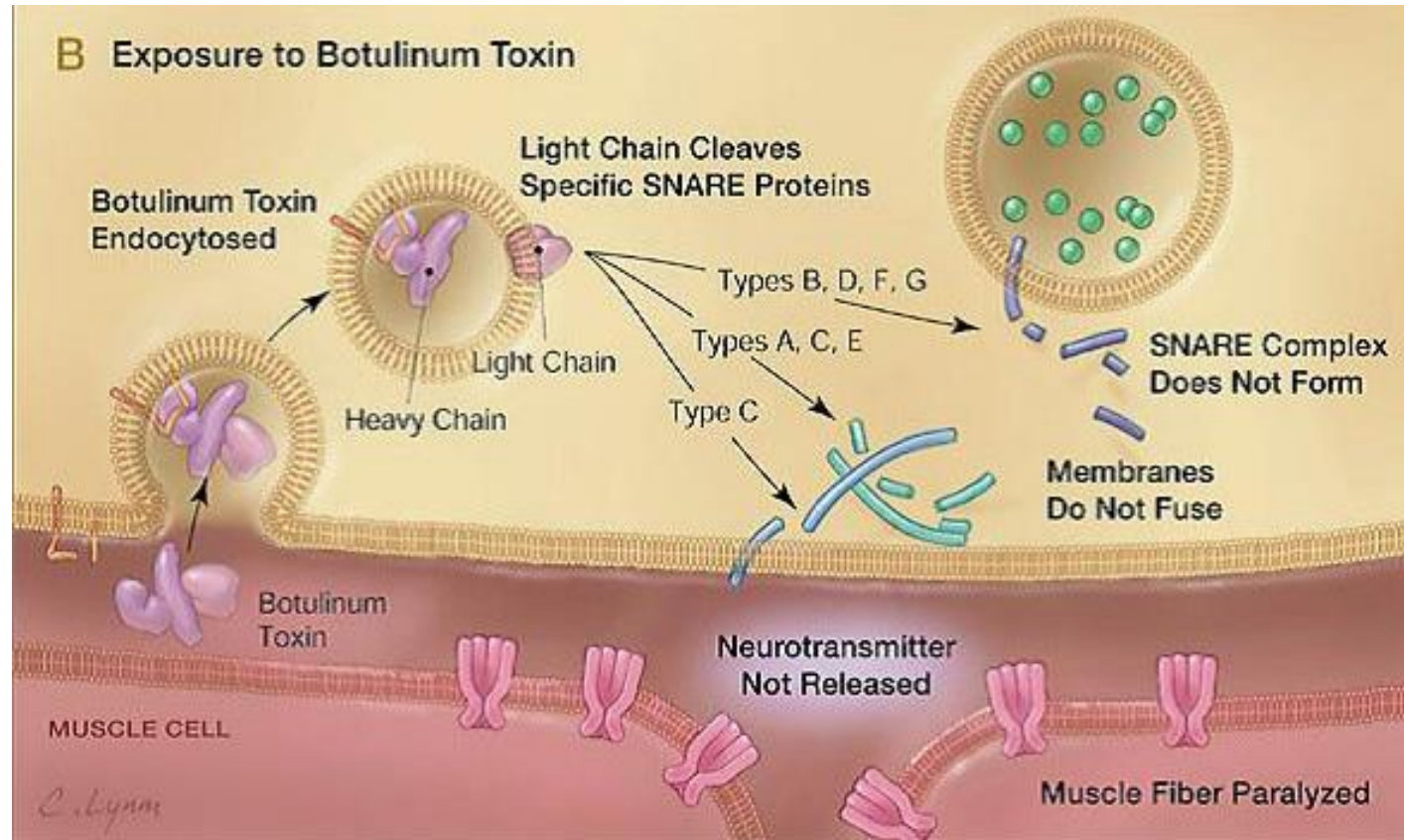
II gén. • Tolterodine (Detrusitol[®])

III gén. { • Darifenacin (Emselex[®])
• Solifenacin (Vesicare[®])

❑ Agoniste β -3

• Mirabegron

Toxine Botulique



Toxine botulique

- Cystoscopie
- Anesthésie locale ou générale
- 100 U / 20cc NaCl
- Injection intra - « detrusorienne »
- 20 points de ponction

Toxine Botulique

- Effets en 2-3 jours
- Env. 70% résultats satisfaisants
- Effet dure 7-9 mois (réinjections possibles)

Neurostimulation sacrée



Initial Management of Urinary Incontinence in Women

